



MODULO 1 • REVELACION

El Desbloqueo

La verdad que nadie te conto sobre tu cuerpo despues del embarazo — y por que nada ha funcionado hasta ahora.

Zero Diastasis™ — Protocolo de 28 dias

Zero Diastasis™

Modulo 1: El Desbloqueo — Primera edicion, 2026.

Aviso importante: Este material es educativo e informativo. No reemplaza la consulta medica profesional. Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulta con tu medico, especialmente si tienes parto reciente (menos de 6 semanas), cesarea, o condiciones medicas preexistentes.

Las tecnicas presentadas se basan en evidencia cientifica publicada en revistas medicas revisadas por pares. Las referencias se incluyen al final del documento.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproduccion total o parcial sin autorizacion.

© 2026 Zero Diastasis™

Contenido

Carta para ti	4
1. La verdad que nadie te conto	5
Que es la diastasis (de verdad)	5
Por que sucede — y por que no es tu culpa	6
Lo que empeora la diastasis (y no te dicen)	7
2. Tu faja invisible	8
El musculo que lo cambia todo: el TVA	8
Por que se "apago" y como reactivarlo	9
3. El test de 2 dedos	10
4. Las 4 fases del protocolo	12
5. Reglas del juego	14
6. Tu tracker de 28 dias	16
Referencias cientificas	17

Carta para ti

Hola, mama.

Si estas leyendo esto, probablemente ya intentaste de todo: abdominales, fajas, dietas, videos de YouTube. Y nada funciona de verdad. O funciona un poco, pero volvio.

Quiero que sepas algo importante antes de empezar: **no es tu culpa.**

Tu cuerpo hizo algo extraordinario — creo vida. Y durante ese proceso, tu abdomen se adapto de la unica forma que podia: separandose para darle espacio a tu bebe. Eso no es un defecto. Es biologia.

El problema no es tu cuerpo. El problema es que nadie te enseno *como* ayudarlo a volver. Peor aun: te dijeron que hicieras exactamente lo que lo empeora.

Tu cuerpo no necesita fuerza. Necesita reprogramacion.

— Zero Diastasis

Este modulo es tu punto de partida. Aqui vas a entender *que* le paso a tu cuerpo, *por que* nada funciona antes, y *que vas a hacer diferente* en los proximos 28 dias.

No necesitas equipos. No necesitas horas. Necesitas 8 minutos al dia y la tecnica correcta.

Empecemos.

Con carino,
El equipo Zero Diastasis

La verdad que nadie te conto

Antes de resolver un problema, necesitas entenderlo de verdad. No con terminos medicos complicados — con palabras reales.

Que es la diastasis (de verdad)

La diastasis de recto — o “diastasis” — es la separacion de los musculos rectos abdominales (los “cuadritos”) que ocurre cuando la linea alba, el tejido conectivo que los une, se estira mas alla de su capacidad normal.

No es una rotura. No es una hernia. Es un **estiramiento excesivo** del tejido conectivo que ocurre naturalmente durante el embarazo para darle espacio a tu bebe.



Lo que dice la ciencia

Estudios demuestran que entre el **66% y el 100%** de las mujeres desarrollan diastasis durante el tercer trimestre del embarazo. Es decir: si tuviste un bebe, es casi seguro que la tuviste o la tienes.

EVIDENCIA CIENTIFICA

“La prevalencia de diastasis de recto abdominal fue del 100% en el tercer trimestre, 52.4% a las 6 semanas posparto, y 39.3% a los 6 meses posparto.”

Sperstad et al. (2016). British Journal of Sports Medicine, 50(17), 1092-1096.

La buena noticia: en la mayoría de los casos, **se puede mejorar significativamente sin cirugía**. Lo que necesitas es el enfoque correcto — que no son abdominales tradicionales.

Por que sucede — y por que no es tu culpa

Durante el embarazo, tu cuerpo produce hormonas como la **relaxina** y el **estrogeno** que ablandan el tejido conectivo para permitir que tu utero crezca. Esto es completamente normal y necesario.

El problema aparece cuando, despues del parto, ese tejido no recupera su tension original. Esto puede pasar por varias razones:

1 Factores hormonales

La relaxina puede permanecer elevada durante meses despues del parto, especialmente si estas amamantando. Esto mantiene el tejido mas “blando” de lo normal.

2 Desactivacion del core profundo

Durante el embarazo, tu cuerpo “apaga” ciertos musculos profundos para darle espacio al bebe. Despues del parto, estos musculos no se “encienden” solos — necesitan ser reactivados conscientemente.

3 Ejercicios incorrectos

Abdominales tipo crunch, planchas intensas y ejercicios de alto impacto **aumentan la presion intraabdominal**, empujando los organos hacia afuera y estirando aun mas la linea alba.



Atencion

Los abdominales clasicos (crunches, sit-ups) pueden **empeorar** la diastasis. Cuando levantas cabeza y hombros sin activar correctamente el core profundo, creas una presion que empuja la linea alba hacia afuera — exactamente lo contrario de lo que necesitas.

EVIDENCIA CIENTIFICA

“Los ejercicios que aumentan la presion intraabdominal, como los crunches convencionales, pueden exacerbar la separacion de la diastasis de recto en mujeres posparto.”

Benjamin et al. (2014). Physiotherapy Theory and Practice, 30(4), 259-268.

Lo que empeora la diastasis (y no te dicen)

Hay acciones cotidianas que, sin saberlo, pueden estar frenando tu recuperacion:

Lo que haces	Por que empeora	Que hacer en su lugar
Abdominales clasicos	Aumentan presion intraabdominal, empujan la linea alba	Activacion del TVA (Modulo 2)
Planchas intensas	Presion excesiva sin control del core profundo	Planchas modificadas (Modulo 4)
Levantarse de la cama de frente	Crea presion directa sobre la linea alba	Girar de lado, usar brazos para subir
Cargar peso sin activar core	Incluye cargar a tu bebe sin preparacion	Activar TVA antes de levantar (Modulo 3)
Estrenimiento cronico	Hacer fuerza aumenta presion abdominal repetidamente	Dieta con fibra, hidratacion, postura correcta

La regla de oro

Si un ejercicio hace que tu abdomen se "asome" hacia afuera (como una cresta o un cono en el centro), **detente inmediatamente**. Esa es la senal de que estas aumentando la separacion.

Tu faja invisible

Dentro de ti existe un musculo que funciona como una faja natural. Se llama transverso abdominal — y es la clave de todo.

El musculo que lo cambia todo: el TVA

El **transverso abdominal (TVA)** es el musculo mas profundo de tu abdomen. Imagina una faja que envuelve tu torso de lado a lado, desde las costillas hasta la pelvis. Eso es tu TVA.

A diferencia del recto abdominal (los “cuadritos” visibles), el TVA no se ve desde afuera. Pero es **el musculo mas importante para cerrar la diastasis** porque:

- **Comprime horizontalmente.** Mientras los abdominales superficiales generan presion hacia afuera, el TVA comprime hacia adentro — acercando los lados de la linea alba.
- **Estabiliza la columna.** Es el primer musculo que se activa (o deberia activarse) antes de cualquier movimiento. Cuando no funciona, otros musculos compensan — y la diastasis empeora.
- **Trabaja con el piso pelvico.** El TVA y el piso pelvico funcionan como un equipo. Cuando activas uno correctamente, el otro responde automaticamente.

EVIDENCIA CIENTIFICA

“El entrenamiento del musculo transverso abdominal demostro reduccion significativa de la distancia inter-rectos en mujeres posparto con diastasis de recto abdominal.”

Keshwani et al. (2021). Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 51(4), 159-167.

Por que se “apago” y como reactivarlo

Durante el embarazo, a medida que tu utero crece, el TVA se estira al maximo. En muchos casos, el cerebro literalmente “olvida” como activar este musculo — es como si se desconectara la senal nerviosa.

Esto explica por que muchas mamás sienten que su abdomen esta “flojo” o “vacio” despues del parto, incluso meses o anos despues. **No es falta de fuerza. Es falta de conexion.**



Tu cuerpo ya sabe que hacer

La reconexion con el TVA no requiere fuerza bruta ni horas de entrenamiento. Requiere **atencion consciente** — aprender a sentir y activar un musculo que siempre estuvo ahí pero que tu cerebro “apago” como mecanismo de proteccion durante el embarazo.

El proceso de reactivacion (lo que haras en los Modulos 2-4):

1

Reconexion (Dias 1-7)

Reaprender a sentir el TVA. Respiracion diafragmatica + primera contraccion consciente. Al dia 3, sentiras “algo diferente” — es la senal volviendo.

2

Compresion (Dias 8-14)

Intensificar la activacion. Agregar tecnicas de tight lacing (compresion lateral). Al dia 14, medidas de nuevo — y veras la diferencia.

3

Anclaje (Dias 15-28)

Automatizar la activacion. Tu TVA empezara a funcionar solo durante actividades cotidianas. Resultado: permanente.

Tu progreso: Dia 0 de 28 — Estas aqui

El test de 2 dedos

Antes de empezar, necesitas saber donde estas. Este autodiagnostico simple te dira el grado de tu diastasis — y sera tu referencia para medir progreso.



Nota importante

Este test es una **herramienta de autoevaluacion**, no un diagnostico medico. Si tienes dudas o tu separacion es mayor a 3 dedos, consulta con un fisioterapeuta especializado en piso pelvico.

Como hacer el test:

1

Acuestate boca arriba

Rodillas dobladas, pies apoyados en el suelo. Relajate completamente.

2

Coloca 2-3 dedos horizontalmente

Justo encima de tu ombligo, con las puntas de los dedos apuntando hacia abajo, perpendiculares a la linea media de tu abdomen.

3

Levanta la cabeza lentamente

Sin levantar los hombros — solo la cabeza, como si quisieras mirar tu ombligo. Siente con los dedos.

4

Mide la separacion

Cuantos dedos caben en el espacio entre los dos lados del musculo? Anota el numero.

5

Repite en 3 puntos

Mide: (a) encima del ombligo, (b) en el ombligo, (c) debajo del ombligo. Anota las 3 medidas.

Interpreta tus resultados:

Separacion	Clasificacion	Que significa
Menos de 2 dedos	Normal / Leve	Dentro del rango normal. El protocolo te ayudara a fortalecer y prevenir.
2-3 dedos	Moderada	Diastasis presente. Excelente candidata para el protocolo. Resultados visibles en 28 dias.
Mas de 3 dedos	Significativa	Consulta medica recomendada antes de empezar. El protocolo puede ayudar, pero necesitas supervision.



No solo mide la distancia

Investigaciones recientes muestran que la **tension de la linea alba** es tan importante como la distancia de separacion. Una separacion de 2 dedos con tejido firme puede ser mejor que 1 dedo con tejido blando. El protocolo trabaja ambos: reducir distancia Y aumentar tension.

EVIDENCIA CIENTIFICA

"La evaluacion de la diastasis de recto no debe basarse unicamente en la distancia inter-rectos, sino tambien en la capacidad de generar tension en la linea alba durante la contraccion abdominal."

Lee & Hodges (2016). Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 46(7), 548-554.

Anota tus medidas iniciales:

Punto de medicion	Dia 0 (hoy)	Dia 7	Dia 14	Dia 28
Encima del ombligo				
En el ombligo				
Debajo del ombligo				
Tension (firme/blanda)				

Las 4 fases del protocolo

28 días. 4 fases. Cada fase construye sobre la anterior. No saltes fases — tu cuerpo necesita esta progresión exacta.



Revelacion

Entender tu cuerpo y medir tu punto de partida

Día 0 (hoy)



Reconexion

Reactivar el TVA con respiracion y vacuum basico

Días 1-7



Compresion

Intensificar con tight lacing y posiciones variadas

Días 8-14



Anclaje

Automatizar la activacion para resultados permanentes

Días 15-28



Por que 28 dias?

La investigacion en neuroplasticidad muestra que el cerebro necesita entre **21 y 30 dias** de practica consistente para crear nuevos patrones de activacion muscular. Nuestro protocolo de 28 dias esta disenado para coincidir con este periodo critico de aprendizaje motor.

Lo que esperar en cada fase:

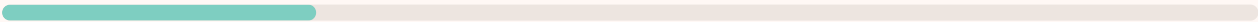
Fase	Dias	Tiempo/dia	Lo que sentiras
Revelacion	Dia 0	15-20 min lectura	"Ahora entiendo por que nada funciona"
Reconexion	1-7	8 min	Dia 3: "Siento algo diferente" — primera activacion consciente del TVA
Compresion	8-14	10 min	Dia 14: "Mi ropa ya cierra diferente" — primera reduccion medible
Anclaje	15-28	12 min	Dia 28: "Ya no tengo que pensar en activarlo" — automatizacion

8 minutos es todo lo que necesitas

El protocolo empieza con 8 minutos al dia. Ocho. Menos que preparar un cafe. Si tienes tiempo para revisar tu telefono, tienes tiempo para esto.

Progresion de intensidad:

Semana 1 (Reconexion) — 8 min/dia



Semana 2 (Compresion) — 10 min/dia



Semanas 3-4 (Anclaje) — 12 min/dia



EVIDENCIA CIENTIFICA

"Programas de ejercicio de baja intensidad y alta frecuencia (sesiones cortas diarias) mostraron mayor adherencia y resultados comparables a programas mas largos e intensos en rehabilitacion posparto."

Reglas del juego

Son pocas, pero son innegociables. Sigue estas reglas y los 28 días funcionaran.

Las 6 reglas:

1 Una sesion por dia. Todos los dias.

Consistencia mata intensidad. 8 minutos diarios superan 1 hora semanal. Tu cerebro necesita repeticion para crear el nuevo patron.

2 Manana o noche — elige tu momento y respetalo.

Lo ideal es hacerlo siempre a la misma hora. Vincular a un habito existente funciona mejor: "despues del cafe" o "antes de dormir".

3 No saltes fases.

Cada fase prepara tu cuerpo para la siguiente. Si saltas a la Compresion sin dominar la Reconexion, no funcionara — y puedes frustrarte.

4 Si sientes dolor, para.

Molestia muscular suave es normal. Dolor agudo, presion en el piso pelvico o sensacion de "bulto" en el abdomen no lo es. Para y consulta.

5 Mide tu progreso los dias 7, 14 y 28.

Vuelve al Test de 2 Dedos. Anota las medidas en la tabla de la pagina 11. Ver los numeros bajar es la mejor motivacion.

6 Se amable contigo misma.

Si pierdes un dia, no intentes compensar con doble sesion. Simplemente retoma al dia siguiente. Progreso > perfeccion.

Consejos practicos para los 28 dias

Tu checklist de inicio:

- ☐ Hice el Test de 2 Dedos y anote mis medidas
- ☐ Elegi mi horario fijo para la sesion diaria
- ☐ Tengo un espacio tranquilo (no necesita ser grande)
- ☐ Descargue los audios del Modulo 2
- ☐ Imprimi (o guarde) el Tracker de 28 Dias

Preguntas frecuentes:

?

Puedo hacer el protocolo si tuve cesarea?

Si, pero espera al menos 8 semanas posparto y la aprobacion de tu medico. La cesarea afecta capas adicionales que necesitan tiempo para sanar.

?

Mi bebe tiene 3 anos — es tarde para empezar?

Nunca es tarde. La diastasis no se corrige sola con el tiempo, pero responde bien al entrenamiento en cualquier momento posparto. Hemos visto resultados en mujeres cuyos hijos tienen 5, 10 e incluso 15 anos.

?

Necesito equipo o ir al gimnasio?

No. Solo necesitas una superficie plana (tu cama o una colchoneta) y 8-12 minutos. Todo se puede hacer en casa, en silencio, mientras tu bebe duerme.

Lo mas dificil ya lo hiciste: decidir empezar. Ahora solo tienes que seguir el plan.

— Zero Diastasis

HERRAMIENTA

Tu tracker de 28 días

Imprime esta pagina y marca cada día que completes tu sesion. Ver los días llenarse es poderoso.

1 RECONEX.	2 RECONEX.	3 RECONEX.	4 RECONEX.	5 RECONEX.	6 RECONEX.	7 MEDIR
8 COMPRES.	9 COMPRES.	10 COMPRES.	11 COMPRES.	12 COMPRES.	13 COMPRES.	14 MEDIR
15 ANCLAJE	16 ANCLAJE	17 ANCLAJE	18 ANCLAJE	19 ANCLAJE	20 ANCLAJE	21 ANCLAJE
22 ANCLAJE	23 ANCLAJE	24 ANCLAJE	25 ANCLAJE	26 ANCLAJE	27 ANCLAJE	28 FINAL

Marca cada día con un ✓ al completar tu sesion.

Estas lista

Manana empieza tu Modulo 2: Reconexion. 8 minutos que van a cambiar como sientes tu cuerpo. Nos vemos ahi.

Referencias científicas

Las siguientes referencias respaldan las afirmaciones y técnicas presentadas en este módulo. Todas son publicaciones revisadas por pares en revistas médicas internacionales.

1. Sperstad, J. B., Tennfjord, M. K., Hilde, G., Ellstrom-Engh, M., & Bo, K. (2016). Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months after childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain. *British Journal of Sports Medicine*, 50(17), 1092-1096.
2. Benjamin, D. R., van de Water, A. T., & Peiris, C. L. (2014). Effects of exercise on diastasis of the rectus abdominis muscle in the antenatal and postnatal periods: a systematic review. *Physiotherapy*, 100(1), 1-8.
3. Lee, D., & Hodges, P. W. (2016). Behavior of the linea alba during a curl-up task in diastasis rectus abdominis: an observational study. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 46(7), 580-589.
4. Keshwani, N., Mathur, S., & McLean, L. (2021). The impact of exercise therapy and abdominal binding in the management of diastasis recti abdominis in the early postpartum period. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 51(4), 159-167.
5. Mota, P., Pascoal, A. G., Carita, A. I., & Bo, K. (2015). Prevalence and risk factors of diastasis recti abdominis from late pregnancy to 6 months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic pain. *Manual Therapy*, 20(1), 200-205.
6. Gluppe, S. L., Hilde, G., Tennfjord, M. K., Engh, M. E., & Bo, K. (2018). Effect of a postpartum training program on the prevalence of diastasis recti abdominis in postpartum primiparous women. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, 48(4), 299-310.
7. Hills, N. F., Graham, R. B., & McLean, L. (2018). Comparison of trunk muscle function between women with and without diastasis recti abdominis at 1 year postpartum. *Physical Therapy*, 98(10), 891-901.
8. Michalska, A., Rokita, W., Wolder, D., Pogorzelska, J., & Kaczmarczyk, K. (2018). Diastasis recti abdominis — a review of treatment methods. *Ginekologia Polska*, 89(2), 97-101.
9. Bo, K., Hilde, G., Tennfjord, M. K., Sperstad, J. B., & Engh, M. E. (2017). Pelvic floor muscle function, pelvic floor dysfunction and diastasis recti abdominis. *International Urogynecology Journal*, 28(6), 853-859.

Zero Diastasis™

Protocolo de 28 días basado en evidencia científica

© 2026 — Todos los derechos reservados